Provão M2 - Urologia e Nefrologia

71 - Turmas A e B - 30/04/26

QUESTÃO 1. Menina de 3 anos, com história de 3 episódios de infecção urinária febril no último ano. Realizou ultrassonografia que evidenciou discreta dilatação pielocalicial à direita. Uretrocistografia miccional demonstrou refluxo vesicoureteral grau III à direita. Qual a melhor conduta inicial?

a) Correção cirúrgica imediata (reimplante ureteral)
b) Antibioticoprofilaxia contínua e seguimento clínico
c) Nefrectomia direita
d) Uso de anticolinérgico isolado

QUESTÃO 2. Menino de 6 anos, com história de ITU febril recorrente e cicatrizes renais à cintilografia com DMSA. UCM revela refluxo vesicoureteral bilateral grau IV. Qual o principal fator que indica intervenção cirúrgica nesse caso?

a) Idade inferior a 10 anos
b) Presença de refluxo unilateral
c) Presença de lesão renal cicatricial associada
d) Ausência de sintomas urinários baixos

QUESTÃO 3. Lactente de 8 meses, com testículo não palpável à direita desde o nascimento. Exame físico sem outras alterações. Qual a melhor conduta?

a) Aguardar até 2 anos para intervenção
b) Solicitar ultrassonografia antes de qualquer conduta
c) Indicar orquidopexia até 12 meses de idade
d) Iniciar terapia hormonal com hCG

QUESTÃO 4. Paciente de 18 anos, com histórico de criptorquidia unilateral não tratada, apresenta testículo atrófico em posição inguinal. Qual a melhor conduta?

a) Orquidopexia tardia
b) Acompanhamento clínico apenas
c) Orquiectomia
d) Terapia hormonal

QUESTÃO 5. Homem de 68 anos, diabético, com febre (39°C), dor lombar intensa e sinais de sepse. TC de abdome evidencia pielonefrite com presença de gás no parênquima renal. Qual o diagnóstico mais provável?

a) Pielonefrite simples
b) Abscesso renal
c) Pielonefrite enfisematosa
d) Pielite aguda

QUESTÃO 6. Paciente de 72 anos, portador de HPB, com retenção urinária e uso de sonda vesical de demora, evolui com febre e bacteriúria significativa. Qual a melhor abordagem inicial?

a) Manter sonda e iniciar antibiótico oral
b) Retirar ou trocar a sonda e iniciar antibiótico empírico
c) Apenas observar, pois é colonização
d) Indicar cirurgia prostática imediata

QUESTÃO 7. O tratamento mais comum para herpes genital é:

a) Aciclovir 400 mg 8/8h
b) Azitromicina 1 g
c) Doxiciclina 100 mg
d) Penicilina G

QUESTÃO 8. O agente etiológico do linfogranuloma venéreo é:

a) Klebsiella granulomatis
b) Haemophilus ducreyi
c) Chlamydia trachomatis
d) Treponema pallidum

QUESTÃO 9. O HPV tipos 6 e 11 estão associados a:

a) Câncer de colo uterino
b) Verrugas anogenitais
c) Neurossífilis

d) Cancro mole

QUESTÃO 10. O exame em campo escuro detecta:
a) Neisseria gonorrhoeae
b) Treponema pallidum
c) Haemophilus ducreyi
d) HPV

QUESTÃO 11. Um homem de 60 anos chega à clínica queixando-se de dores de cabeça persistentes há quatro semanas. Desde que foi diagnosticado com pressão alta, ele segue uma dieta pobre em sódio e se exercita 30 minutos por dia. É importante observar no histórico médico anterior que sua taxa de filtração glomerular estava no 3º percentil em sua última consulta. Na consulta de hoje, seu Índice de Massa Corporal é 31 e sua pressão arterial é 142/93 mm Hg. Qual o melhor tratamento inicial para a hipertensão?
a) Inibidores da enzima conversora de angiotensina
b) Análogos de purina
c) Anti-inflamatórios não esteroidais
d) Diuréticos

QUESTÃO 12. Para facilitar a micção em paciente com hiperplasia benigna de próstata, qual das seguintes classes de medicamentos é mais adequada?
a) Colinérgicos
b) Anticolinérgicos
c) Beta-adrenérgicos
d) Alfabloqueadores

QUESTÃO 13. Paciente feminina, 70 anos, com quadro de febre alta (39 ºC), calafrios, náuseas e dor lombar direita há 3 dias. Refere também disúria e polaciúria. Ao exame físico, apresenta dor à punho-percussão lombar direita (sinal de Giordano positivo). EAS (urina tipo I): Densidade: 1,018 (VR 1,015-1,025); pH: 6,0 (VR 5,0-7,0); Glicose: negativa; Proteínas: (+); Nitrito: positivo; Esterase leucocitária: positiva. Sedimento urinário: Leucócitos: 200.000/mL (VR < 10.000); Hemácias: 12.000/mL (VR < 5.000); Bactérias: numerosas; Cilindros leucocitários: presentes em vários campos (VR: ausentes). Exames séricos: Leucócitos: 17.000/mm³ (VR 4.000-10.000); PCR: 110 mg/L (VR < 5). Qual a melhor interpretação clínico-laboratorial?
a) Cistite aguda
b) Síndrome nefrótica
c) Pielonefrite aguda
d) Exame sem alterações significativas

QUESTÃO 14. Paciente feminina, 66 anos, com queixa de disúria, polaciúria e urgência urinária há 3 dias. Nega febre e dor lombar. EAS (urina tipo I): Densidade: 1,020 (VR 1,015-1,025); pH: 6,0 (VR 5,0-7,0); Glicose: negativa; Proteínas: traços; Nitrito: positivo (VR negativo); Esterase leucocitária: positiva. Sedimento urinário: Leucócitos: 80.000/mL (VR < 10.000); Hemácias: 5.000/mL (VR < 5.000); Bactérias: numerosas; Cilindros: ausentes. Urocultura: Crescimento bacteriano: 10^5 UFC/mL (VR < 10^3). Qual a melhor interpretação clínico-laboratorial (Escolha a melhor alternativa)?
a) Contaminação da amostra urinária
b) Infecção urinária bacteriana alta (pielonefrite)
c) Infecção viral do trato urinário
d) Infecção urinária bacteriana baixa (cistite)

QUESTÃO 15. Assinale a alternativa que melhor correlacione a glomerulopatia com sua descrição histológica e causa secundária associada:
a) Glomerulonefrite membranosa - presença de espículas na coloração pela prata - nefrite lúpica classe V
b) Glomeruloesclerose segmentar e focal - duplicação da membrana basal - linfoma
c) Doença por lesão mínima - proliferação endocapilar - mieloma múltiplo
d) Nefropatia por IgA - espessamento da membrana basal - uso de anti-inflamatório

QUESTÃO 16. A síndrome nefrítica se caracteriza por ter como mecanismo deflagrador da glomerulonefrite:
a) Perda da carga elétrica da membrana basal glomerular
b) Alteração podocitária com perda de macroproteínas
c) Proliferação endocapilar e perda da área de filtração glomerular
d) Fibrose intersticial

QUESTÃO 17. Na glomerulonefrite rapidamente progressiva, crescêntica, marque a alternativa que correlacione o tipo de glomerulonefrite crescêntica, achados na imunofluorescência da biópsia renal e doenças associadas:
a) Tipo III - imunofluorescência com depósitos de imunoglobulinas padrão linear - Glomerulonefrite pauci-imune
b) Tipo II - imunofluorescência com depósitos de imunoglobulinas padrão granular - nefrite lúpica (mediada por imunocomplexos)
c) Tipo I - imunofluorescência com ausência de depósitos de imunoglobulinas - vasculite anca associada
d) Tipo IV - imunofluorescência com depósitos de imunoglobulinas padrão linear - síndrome de Churg Strauss

QUESTÃO 18. Paciente jovem, 19 anos, sexo masculino, raça negra, apresenta quadro de urina espumosa, ganho de peso de 9 Kg em 2 semanas, proteinúria de 24 horas de 5,4 g/24 horas, albumina de 2,1 dl, colesterol de 298 mg/dL, EAS com proteinúria 4+, hematúria microscópica, leucocitúria estéril, função renal normal e PA discretamente elevada. Diante destas características clínicas e laboratoriais, o diagnóstico presuntivo é:
a) Síndrome nefrótica, glomeruloesclerose segmentar e focal (GESF)
b) Síndrome nefrótica, lesões mínimas
c) Síndrome nefrítica, vasculite pauci-imune
d) Síndrome nefrítica, glomerulonefrite pós infecciosa

QUESTÃO 19. Na ultrassonografia, qual é a característica típica de um cálculo renal?
a) Massa sólida com bordas irregulares;
b) Imagem anecoica com bordas finas e regulares;
c) Imagem hiperecogênica com sombra acústica posterior;
d) Massa heterogênea com septos internos;

QUESTÃO 20. Qual dessas é a principal causa de Injúria Renal Aguda renal?
a) Nefrite túbulo-intersticial
b) Necrose cortical
c) Necrose tubular aguda
d) Glomerulonefrite rapidamente progressiva

QUESTÃO 21. Na injúria renal aguda, a doença renal aguda corresponde a qual período?
a) Sete primeiros dias.
b) Período menor que 90 dias.
c) Depois dos primeiros 90 dias.
d) Todas as respostas anteriores.

QUESTÃO 22. Qual desses pacientes tem menor risco para injúria renal aguda?
a) Em uso de diurético
b) Idoso
c) Diabético
d) Asmático

QUESTÃO 23. A doença renal policística autossômica dominante tipo 1
a) Ocorre por mutação no gene PKD2
b) Ocorre por mutação no cromossomo 4
c) Tem o fenótipo pior que o tipo 2.
d) Acomete mais mulheres que homens.

QUESTÃO 24. Na hiponatremia dilucional:
a) O sódio está baixo por perda de sódio na urina
b) Um exemplo é a doença renal crônica

c) O sódio está baixo por redistribuição da água para o terceiro espaço
d) O melhor tratamento é o uso de tiazídicos.

QUESTÃO 25. David Giordano descreveu um sinal na Itália, mas que na Polônia é chamado de sinal de Goldflam, no leste europeu é chamado de sinal de Pastemacki, onde foi relatado pelo clínico Fiodor Ignatjevich Pastemacki, da Bielorrússia. O primeiro a descrever este sinal, porém, foi Jonh Benjamin Murphy em 1884, dando o nome de sensibilidade do ângulo costovertebral. Esse sinal pode sugerir:
a) Pielonefrite
b) Urolitíase
c) Abscesso renal
d) Todas as anteriores.

QUESTÃO 26. Qual desses testes é o recomendado a ser usado pela Sociedade Internacional de Nefrologia para estimar a Taxa de Filtração Glomerular em adultos, a partir da creatinina sérica?
a) Cockoft-Gault
b) CKD-EPI 2021
c) Salazar-Corcoran
d) MDRD

QUESTÃO 27. Na nefropatia diabética qual dos achados histológicos é mais comum:
a) Espessamento difuso da membrana basal glomerular com focos de desdobramento.
b) Padrão de Glomerulonefrite Proliferativa com necrose
c) Espessamento mesangial positivo para Vermelho Congo
d) Presença de nódulos hialinos mesangiais (glomeruloesclerose nodular)

QUESTÃO 28. Marque a alternativa certa quanto ao diabetes e o rim:
a) Na nefropatia diabética a microalbuminúria está acima de 300mcg/mg de creatinina.
b) Na doença renal do diabetes se a taxa de filtração glomerular estiver acima de 100ml/min/1,73m2SC, esse diagnóstico não é confirmado.
c) Na glomerulopatia diabética ocorre a hialinose de arteríolas aferentes, poupando as arteríolas eferentes.
d) O último estágio da doença renal do diabetes é atingido pela minoria dos diabéticos.

QUESTÃO 29. Um paciente diabético com TFG = 38ml/min/1,73m2SC e microalbuminúria de 350mcg/mgCr está em qual classificação da DRC?
a) G5A3
b) G4A2
c) G3bA3
d) G3aA2

QUESTÃO 30. Na síndrome de Alport a herança genética pode ser:
a) Autossômica recessiva
b) Autossômica dominante
c) Ligada ao X
d) Todas as respostas anteriores.

PROVÃO M2 | 71ª TURMA

Gabarito técnico comentado - Urologia e Nefrologia | Questões 1 a 30 | Prova de 30/04/2026

Documento complementar. As quatro páginas da prova original foram preservadas no início do arquivo. Este apêndice explicita o gabarito mais fundamentado, os motivos de acerto/erro de cada alternativa e ressalvas quando os dados fornecidos não justificam uma conclusão categórica.

1. Gabarito resumido

01 B	**02 C**	**03 C**	**04 C***	**05 C**
06 B	**07 A**	**08 C**	**09 B**	**10 B**
11 A*	**12 D**	**13 C**	**14 D**	**15 A**
16 C	**17 B**	**18 A**	**19 C**	**20 C**
21 B*	**22 D**	**23 C**	**24 B**	**25 D**
26 B	**27 D***	**28 D**	**29 C**	**30 D**

* As questões 4, 11, 21 e 27 exigem ressalvas específicas. O símbolo * significa “letra mais defensável com ressalva”, não uma certeza absoluta. Outras questões também contêm condicionantes clínicos explicados adiante.

2. Comentários por alternativa

QUESTÃO 01 - Refluxo vesicoureteral (RVU) grau III em criança de 3 anos | Gabarito: B

A) Incorreta. O refluxo grau III não impõe reimplante ureteral imediato; a decisão depende de infecções de escape, função renal, cicatrizes e disfunção vesicointestinal.

B) Correta entre as opções. Profilaxia antimicrobiana contínua e acompanhamento são uma estratégia inicial apropriada para RVU grau III sintomático com ITUs febris recorrentes.

C) Incorreta. Não há indicação de retirar um rim apenas pela presença de RVU unilateral com discreta dilatação.

D) Incorreta. Anticolinérgicos isolados não tratam RVU e só têm papel em disfunções vesicais selecionadas.

Nota crítica: A profilaxia não é automática para todo RVU: recomendações atuais individualizam seu uso, sobretudo pelo risco de resistência. A abordagem inclui pesquisa de constipação e disfunção vesicointestinal.

Fundamentação: [R01], [R02]

QUESTÃO 02 - RVU bilateral grau IV e cicatrizes renais | Gabarito: C

A) Incorreta. Idade abaixo de 10 anos, isoladamente, não determina operação.

B) Incorreta. O refluxo descrito é bilateral; sua bilateralidade, especialmente com alto grau, aumenta o risco.

C) Correta como fator decisivo entre os apresentados. Cicatrizes demonstradas por DMSA indicam acometimento parenquimatoso e reforçam a consideração de correção em RVU grau IV recorrente.

D) Incorreta. A ausência de sintomas urinários baixos não exclui RVU grave nem afasta risco renal.

Nota crítica: Cicatriz não é indicação cirúrgica obrigatória isolada. Grau, infecções febris apesar da profilaxia, função renal, disfunção vesicointestinal e preferências familiares devem ser avaliados em conjunto.

Fundamentação: [R01]

QUESTÃO 03 - Testículo não palpável aos 8 meses | Gabarito: C

A) Incorreta. Esperar até os 2 anos atrasa o tratamento e pode comprometer a função testicular.

B) Incorreta. Ultrassonografia rotineira não é necessária para definir o manejo do testículo não palpável, pois não elimina a necessidade de exploração especializada.

C) Correta. Está indicada avaliação cirúrgica e orquidopexia precoce, idealmente entre 6 e 12 meses e, em geral, até 18 meses de idade.

D) Incorreta. Terapia hormonal com hCG não é recomendada como substituto rotineiro da orquidopexia.

Nota crítica: Na criança com testículo não palpável, exame sob anestesia e laparoscopia/exploração podem ser necessários. A letra C é a melhor, ainda que diferentes diretrizes aceitem cirurgia até 18 meses.

Fundamentação: [R03], [R29]

QUESTÃO 04 - Criptorquidia persistente após a puberdade, com atrofia | Gabarito: C*

A) Possível em alguns protocolos: a EAU recomenda orquidopexia em testículos palpáveis após a puberdade. Entretanto, atrofia importante favorece discutir orquiectomia, sobretudo com testículo oposto normal.

B) Incorreta. Apenas observar não resolve a exposição a risco neoplásico nem avalia adequadamente o testículo inguinal atrófico.

C) Mais defensável diante de testículo inguinal atrófico no pós-púbere, se contralateral normal: a AUA admite orquiectomia em testículos muito hipoplásicos ou em pacientes pós-púberes.

D) Incorreta. Hormonioterapia tem pouca utilidade nessa apresentação tardia.

Nota crítica: QUESTÃO COM RESSALVA: a EAU 2026 indica, em regra, orquidopexia para testículo palpável e orquiectomia para testículo intra-abdominal após a puberdade com contralateral normal; a AUA admite orquiectomia em testículo acentuadamente hipoplásico. Sem avaliação do testículo contralateral e grau objetivo de atrofia, a opção C não é incondicional.

Fundamentação: [R03], [R29]

QUESTÃO 05 - Pielonefrite enfisematosa | Gabarito: C

A) Incorreta. A presença de gás no parênquima renal indica forma complicada, não pielonefrite simples.

B) Incorreta como diagnóstico mais adequado. Abscesso renal forma coleção purulenta; o achado definidor descrito é gás parenquimatoso.

C) Correta. Infecção renal necrosante, com gás no parênquima à TC e associação frequente com diabetes e sepse, caracteriza pielonefrite enfisematosa.

D) Incorreta. Pielite acomete a pelve renal; não explica adequadamente gás no parênquima.

Nota crítica: Trata-se de urgência, com antibióticos intravenosos, suporte à sepse e avaliação de drenagem/desobstrução; em casos selecionados pode ser necessária nefrectomia.

Fundamentação: [R30]

QUESTÃO 06 - Infecção urinária associada a sonda | Gabarito: B

A) Incorreta como regra. Manter cateter possivelmente colonizado/biofilme sem reavaliar sua necessidade é inadequado, e via oral pode ser insuficiente conforme gravidade.

B) Correta. Deve-se retirar a sonda se desnecessária ou trocá-la quando indicado, colher cultura antes de antibiótico e iniciar tratamento empírico ajustado à gravidade.

C) Incorreta. Febre e quadro infeccioso em cateterizado tornam a hipótese de ITU sintomática relevante, em contraste com bacteriúria assintomática.

D) Incorreta. Cirurgia prostática imediata não constitui o manejo inicial da infecção aguda.

Nota crítica: A troca é especialmente recomendada quando o cateter está há mais de 2 semanas e ainda é necessário. Antimicrobianos devem cobrir o contexto e ser revistos pelo antibiograma.

Fundamentação: [R04]

QUESTÃO 07 - Tratamento de herpes genital | Gabarito: A

A) Correta. Aciclovir 400 mg por via oral a cada 8 horas por 7 a 10 dias é esquema recomendado para primeiro episódio.

B) Incorreta. Azitromicina é antibiótico, não antiviral para HSV.

C) Incorreta. Doxiciclina é antibiótico útil para outras ISTs, não para herpes genital.

D) Incorreta. Penicilina G é tratamento para sífilis, sem atividade clínica contra HSV.

Nota crítica: A duração e dose variam conforme primeiro episódio, recidiva, supressão crônica, gravidade e função renal. O enunciado não especifica o cenário; A é a opção correta disponível.

Fundamentação: [R05]

QUESTÃO 08 - Etiologia do linfogranuloma venéreo | Gabarito: C

A) Incorreta. Klebsiella granulomatis é agente do donovanose (granuloma inguinal).

B) Incorreta. Haemophilus ducreyi causa cancro mole.

C) Correta. O linfogranuloma venéreo é causado por Chlamydia trachomatis dos sorovares L1, L2 e L3.

D) Incorreta. Treponema pallidum provoca sífilis.

Fundamentação: [R06]

QUESTÃO 09 - HPV de baixo risco, tipos 6 e 11 | Gabarito: B

A) Incorreta como associação principal. Câncer cervical relaciona-se sobretudo aos genótipos HPV de alto risco, como 16 e 18.

B) Correta. Tipos 6 e 11 são responsáveis por cerca de 90% das verrugas anogenitais (condilomas acuminados).

C) Incorreta. Neurossífilis decorre de infecção por Treponema pallidum.

D) Incorreta. Cancro mole é causado por Haemophilus ducreyi.

Fundamentação: [R07]

QUESTÃO 10 - Exame de campo escuro | Gabarito: B

A) Incorreta. Neisseria gonorrhoeae é diplococo Gram-negativo; diagnóstico se faz preferencialmente por testes moleculares e, conforme situação, cultura.

B) Correta. Microscopia em campo escuro pode demonstrar espiroquetas móveis de Treponema pallidum em exsudato fresco de lesões adequadas.

C) Incorreta. Haemophilus ducreyi não é identificado pelo método específico clássico para espiroquetas.

D) Incorreta. HPV é vírus identificado por métodos moleculares/citopatológicos, não por campo escuro.

Nota crítica: O exame de campo escuro tem limitações de disponibilidade e deve evitar material oral devido a treponemas comensais.

Fundamentação: [R08]

QUESTÃO 11 - Anti-hipertensivo em paciente com possível disfunção renal | Gabarito: A*

A) Melhor resposta presumida. IECA pode controlar a pressão e oferecer benefício renal principalmente quando há albuminúria; requer monitorar creatinina e potássio.

B) Incorreta. Análogos de purina não são anti-hipertensivos e alguns podem ter toxicidade sistêmica.

C) Incorreta. AINEs podem elevar a pressão arterial e deteriorar função renal, não sendo opção terapêutica para hipertensão.

D) Plausível em circunstâncias específicas. Diuréticos são anti-hipertensivos adequados, especialmente com retenção de volume, mas faltam dados para considerá-los superiores ao IECA.

Nota crítica: QUESTÃO INSUFICIENTEMENTE ESPECIFICADA: “TFG no 3º percentil” não fornece valor em mL/min/1,73 m² nem demonstra albuminúria. Diretrizes não estabelecem IECA como única primeira escolha para toda DRC sem albuminúria; ausência de PA seriada, potássio e creatinina impede conduta individualizada.

Fundamentação: [R09], [R26]

QUESTÃO 12 - Sintomas urinários da hiperplasia benigna da próstata | Gabarito: D

A) Incorreta. Colinérgicos aumentam atividade contrátil vesical, não são tratamento habitual da obstrução prostática.

B) Incorreta como melhor opção. Antimuscarínicos podem aliviar urgência/frequência em casos selecionados, com cautela em retenção, mas não reduzem resistência da saída vesical.

C) Incorreta. Agonistas beta-3 são usados sobretudo para sintomas de armazenamento vesical, não são a principal classe para melhorar esvaziamento obstrutivo.

D) Correta. Alfabloqueadores (como tansulosina) relaxam a musculatura lisa do colo vesical e da próstata, melhorando fluxo e sintomas de esvaziamento.

Fundamentação: [R10]

QUESTÃO 13 - Infecção urinária alta: clínica e sedimento | Gabarito: C

A) Incorreta. Cistite isolada costuma causar disúria e urgência sem febre alta, Giordano positivo e comprometimento sistêmico.

B) Incorreta. Síndrome nefrótica caracteriza-se por proteinúria intensa, hipoalbuminemia e edema, ausentes nessa apresentação como síndrome principal.

C) Correta. Febre, calafrios, dor lombar, Giordano positivo, nitrito, piúria, bacteriúria e cilindros leucocitários sustentam pielonefrite aguda.

D) Incorreta. Há alterações inflamatórias e urinárias relevantes.

Nota crítica: Cilindros leucocitários sugerem processo inflamatório renal, mas não são exclusivos de pielonefrite: também aparecem em nefrite intersticial e outras nefropatias.

Fundamentação: [R11]

QUESTÃO 14 - Cistite bacteriana em mulher idosa | Gabarito: D

A) Incorreta. Disúria, polaciúria e urgência associadas a piúria, nitrito e cultura monomicrobiana significativa favorecem infecção verdadeira.

B) Incorreta. Sem febre, dor lombar ou sinais sistêmicos, não há quadro típico de pielonefrite.

C) Incorreta. Nitrito positivo e urocultura bacteriana favorecem etiologia bacteriana, não viral.

D) Correta. Sintomas do trato urinário baixo associados à bacteriúria e leucocitúria definem quadro de cistite bacteriana.

Nota crítica: O corte de 10^5 UFC/mL não é necessário em toda mulher sintomática; limiares menores também podem ser clinicamente relevantes.

Fundamentação: [R11]

QUESTÃO 15 - Glomerulopatia, histologia e causa secundária | Gabarito: A

A) Correta. Nefropatia membranosa pode apresentar “espículas” na impregnação pela prata; nefrite lúpica classe V é uma causa de padrão membranoso secundário.

B) Incorreta. Duplicação da membrana basal é sugestiva de padrão membranoproliferativo, não achado clássico de glomeruloesclerose segmentar e focal.

C) Incorreta. Doença por lesões mínimas tem microscopia óptica habitualmente pouco alterada e apagamento podocitário na eletrônica; não proliferação endocapilar.

D) Incorreta. Nefropatia por IgA apresenta depósitos mesangiais dominantes de IgA, não apenas espessamento da MB; AINEs se associam a outras lesões renais.

Fundamentação: [R12], [R13]

QUESTÃO 16 - Mecanismo da síndrome nefrítica | Gabarito: C

A) Incorreta. Alterações da seletividade de carga da barreira glomerular são tradicionalmente relacionadas a proteinúria.

B) Incorreta. Lesão podocitária intensa com proteinúria maciça se relaciona mais à síndrome nefrótica.

C) Correta como descrição fisiopatológica clássica. Inflamação/proliferação endocapilar reduz a superfície efetiva de filtração e pode causar oligúria, hipertensão e hematúria.

D) Incorreta. Fibrose intersticial caracteriza lesão crônica e não é mecanismo geral desencadeador de glomerulonefrite nefrítica.

Nota crítica: Nem toda síndrome nefrítica exige proliferação endocapilar no exame histológico; a alternativa descreve o padrão inflamatório clássico cobrado.

Fundamentação: [R14]

QUESTÃO 17 - Glomerulonefrite rapidamente progressiva (crescêntica) | Gabarito: B

A) Incorreta. Tipo III é pauci-imune, com poucos ou nenhum depósito na imunofluorescência; padrão linear é do tipo I.

B) Correta. Tipo II decorre de imunocomplexos, com padrão granular, podendo ocorrer na nefrite lúpica.

C) Incorreta. Tipo I apresenta anticorpos anti-membrana basal glomerular em padrão linear; vasculite ANCA é mais frequentemente tipo III.

D) Incorreta. “Tipo IV” pode representar dupla positividade ANCA/anti-MBG, e Churg-Strauss (EGPA) é vasculite associada a ANCA/pauci-imune quando envolve rim.

Fundamentação: [R14]

QUESTÃO 18 - Síndrome nefrótica em jovem com provável GESF | Gabarito: A

A) Correta como hipótese presuntiva. Proteinúria 5,4 g/dia, albumina 2,1 (provavelmente g/dL), edema e hiperlipidemia definem síndrome nefrótica; etnia referida, hematúria e PA elevada favorecem GESF.

B) Menos provável. Lesões mínimas causam síndrome nefrótica, mas a hematúria/hipertensão e o contexto tornam GESF uma hipótese mais forte; não há exclusão definitiva.

C) Incorreta. Vasculite pauci-imune costuma causar síndrome nefrítica com declínio de função renal, hematúria glomerular e cilindros hemáticos.

D) Incorreta. Glomerulonefrite pós-infecciosa cursa classicamente com padrão nefrítico, não síndrome nefrótica isolada.

Nota crítica: Não é possível distinguir GESF de doença por lesões mínimas com certeza apenas pelos dados: confirmação etiológica costuma depender de biópsia renal. O enunciado informa “albumina 2,1 dl”, unidade incorreta; foi interpretada como g/dL.

Fundamentação: [R25], [R27]

QUESTÃO 19 - Ultrassonografia de cálculo renal | Gabarito: C

A) Incorreta. Massa irregular sólida orienta mais para neoplasia ou outra lesão sólida do que cálculo típico.

B) Incorreta. Imagem anecoica com parede fina e regular sugere cisto simples.

C) Correta. Cálculos aparecem como foco hiperecogênico, frequentemente com sombra acústica posterior.

D) Incorreta. Massa heterogênea septada faz pensar em lesão complexa, não cálculo isolado.

Nota crítica: Pequenos cálculos podem não produzir sombra nítida, e o artefato de cintilação (twinkling) ao Doppler pode ajudar.

Fundamentação: [R23]

QUESTÃO 20 - Causa mais comum de injúria renal aguda intrínseca | Gabarito: C

A) Incorreta como causa mais frequente. Nefrite túbulo-intersticial aguda é reconhecida, frequentemente associada a fármacos, mas é menos comum.

B) Incorreta. Necrose cortical é forma grave e rara de lesão renal isquêmica.

C) Correta. Necrose/lesão tubular aguda isquêmica ou nefrotóxica é a causa mais comum de IRA intrínseca (renal).

D) Incorreta. Glomerulonefrite rapidamente progressiva é causa importante e urgente, mas menos frequente.

Nota crítica: A causa global de IRA pode ser pré-renal em muitos contextos; a palavra “renal” no enunciado é entendida como intrínseca, não qualquer IRA.

Fundamentação: [R24]

QUESTÃO 21 - Período de doença renal aguda (AKD/DRA) | Gabarito: B*

A) Incorreta como definição completa. Os primeiros sete dias correspondem à janela de IRA; doença renal aguda engloba alterações em período inferior a 90 dias.

B) Correta entre as opções. DRA/AKD refere-se a anormalidade renal aguda ou subaguda com duração menor que três meses.

C) Incorreta. Anormalidades persistentes por pelo menos três meses podem atender à definição de DRC.

D) Incorreta. Não podem estar corretos simultaneamente intervalos mutuamente incompatíveis.

Nota crítica: Ressalva terminológica: no modelo temporal pós-IRA da ADQI, AKD frequentemente descreve a persistência ou evolução da lesão de 7 a 90 dias; nos critérios gerais KDIGO, AKD envolve condições com duração <3 meses. Por isso B é a melhor letra.

Fundamentação: [R16], [R17]

QUESTÃO 22 - Fatores associados ao risco de IRA | Gabarito: D

A) Incorreta como menor risco. Diuréticos podem contribuir para depleção volêmica ou agravar hipoperfusão em certas condições.

B) Incorreta. Idade avançada aumenta suscetibilidade por comorbidades e reserva renal reduzida.

C) Incorreta. Diabetes está associado a doença renal e maior risco de IRA.

D) Correta como escolha relativa. Asma, por si só, não é fator clássico de risco renal comparável aos demais.

Nota crítica: O risco verdadeiro é individual e depende de condições associadas, hemodinâmica, medicamentos e gravidade clínica.

Fundamentação: [R16]

QUESTÃO 23 - Doença renal policística autossômica dominante tipo 1 | Gabarito: C

A) Incorreta. PKD2 está ligado ao fenótipo tipo 2, não ao tipo 1.

B) Incorreta. PKD2 localiza-se no cromossomo 4; PKD1, no cromossomo 16.

C) Correta como tendência populacional. A doença relacionada a PKD1 costuma evoluir mais precocemente e com maior gravidade do que PKD2.

D) Incorreta. A herança autossômica dominante afeta ambos os sexos, sem predominância feminina obrigatória.

Nota crítica: Trata-se de tendência: gravidade depende da variante e de fatores modificadores; há sobreposição clínica entre genótipos.

Fundamentação: [R18], [R19]

QUESTÃO 24 - Hiponatremia dilucional | Gabarito: B

A) Incorreta como explicação típica. Perda renal de sódio produz hiponatremia por depleção de sódio, não por excesso relativo de água livre.

B) Correta como exemplo possível. DRC avançada pode limitar a excreção de água livre, favorecendo retenção hídrica e diluição do sódio.

C) Incorreta. Terceiro espaço produz distribuição anômala de líquidos e hipovolemia efetiva, mas não define, isoladamente, a fisiopatologia típica de hiponatremia dilucional.

D) Incorreta. Tiazídicos são causa conhecida de hiponatremia e não são tratamento universal da hiponatremia dilucional.

Nota crítica: Nem toda DRC produz hiponatremia; são necessários contexto de ingestão hídrica, capacidade de diluição e volemia. Tratar exige avaliação clínica e da osmolaridade.

Fundamentação: [R09]

QUESTÃO 25 - Sensibilidade do ângulo costovertebral (Giordano) | Gabarito: D

A) Correta como possibilidade. Pielonefrite pode causar dor à punho-percussão lombar.

B) Correta como possibilidade. Urolitíase, especialmente obstrutiva, pode produzir dor no ângulo costovertebral.

C) Correta como possibilidade. Abscesso renal pode provocar sensibilidade lombar importante.

D) Correta como resposta agregadora. Todos os três diagnósticos anteriores podem cursar com sinal de Giordano positivo.

Nota crítica: O sinal é inespecífico: não diferencia, sozinho, infecção renal, obstrução por cálculo ou outras causas de dor lombar.

Fundamentação: [R11], [R23]

QUESTÃO 26 - Equação de estimativa da TFG a partir da creatinina | Gabarito: B

A) Incorreta como equação preferida para classificar TFG. Cockcroft-Gault estima depuração de creatinina, ainda útil em ajustes de doses de determinados fármacos.

B) Correta. CKD-EPI 2021 baseada em creatinina, sem coeficiente racial, é equação validada e amplamente recomendada para estimar TFG em adultos.

C) Incorreta. Salazar-Corcoran é fórmula mais antiga, proposta para estimativa de depuração em obesidade, não padrão de eTFG.

D) Incorreta como primeira escolha atual. MDRD é fórmula histórica com desempenho inferior ao CKD-EPI em diversos intervalos de TFG.

Nota crítica: Quando disponível e decisiva para conduta, a combinação creatinina + cistatina C melhora a precisão; não confundir estimativa de TFG e medidas para ajuste farmacológico.

Fundamentação: [R09], [R20]

QUESTÃO 27 - Histologia na nefropatia diabética | Gabarito: D*

A) Parcialmente correta no espessamento difuso da MBG, alteração frequente e precoce; porém “focos de desdobramento” não é uma característica definidora e sugere outros padrões, como membranoproliferativo.

B) Incorreta. Proliferação com necrose é padrão inflamatório de glomerulonefrite, não alteração típica da nefropatia diabética.

C) Incorreta. Vermelho Congo positivo sugere depósito de amiloide, não simples expansão mesangial diabética.

D) Correta como achado CARACTERÍSTICO: nódulos mesangiais de Kimmelstiel-Wilson definem glomeruloesclerose nodular diabética.

Nota crítica: QUESTÃO COM IMPRECISÃO: o enunciado pede o achado “mais comum”. Espessamento da MBG e expansão mesangial difusa são mais comuns/precoces que os nódulos de Kimmelstiel-Wilson (achado mais específico). A letra D é a resposta provavelmente pretendida pelo autor, mas o superlativo dificulta considerá-la literalmente correta; a redação de A também contém um elemento atípico (“desdobramento”). Cabe revisão do item.

Fundamentação: [R15], [R21], [R25], [R28]

QUESTÃO 28 - Afirmações sobre diabetes e doença renal | Gabarito: D

A) Incorreta. O termo tradicional microalbuminúria corresponde a albuminúria moderadamente aumentada (UACR 30–300 mg/g); acima de 300 caracteriza A3.

B) Incorreta. Hiperfiltração ou TFG preservada/elevada não exclui lesão renal diabética; pode haver albuminúria e alterações precoces.

C) Incorreta. Na nefropatia diabética, podem ocorrer hialinose das arteríolas aferentes E eferentes, esta última particularmente sugestiva.

D) Correta em termos epidemiológicos. Apenas uma parcela dos diabéticos evolui para estágio terminal de insuficiência renal.

Nota crítica: O diagnóstico atual de DRC diabética não depende exclusivamente de albuminúria; confirmar cronicidade e excluir outras etiologias quando houver sinais atípicos.

Fundamentação: [R09], [R21]

QUESTÃO 29 - Estadiamento DRC pelo par G e A | Gabarito: C

A) Incorreta. G5 significa TFG inferior a 15, não 38 mL/min/1,73 m².

B) Incorreta. G4 exige TFG de 15–29 e A2 ACR de 30–300 mg/g; ambos incompatíveis.

C) Correta. TFG 38 classifica G3b (30–44); ACR 350 mcg/mg equivale numericamente a 350 mg/g, categoria A3 (>300).

D) Incorreta. G3a é TFG 45–59 e A2 vai até 300 mg/g; nenhuma corresponde aos dados.

Nota crítica: DRC exige persistência por pelo menos 3 meses (ou evidência inequívoca de cronicidade). “Microalbuminúria 350” é nomenclatura inadequada: 350 mg/g corresponde a albuminúria A3.

Fundamentação: [R09]

QUESTÃO 30 - Padrões de herança da síndrome de Alport | Gabarito: D

A) Verdadeira. Alterações bialélicas em COL4A3 ou COL4A4 causam síndrome de Alport autossômica recessiva.

B) Verdadeira. Variantes heterozigóticas em COL4A3 ou COL4A4 podem causar doença autossômica dominante.

C) Verdadeira. Variantes em COL4A5 causam síndrome de Alport ligada ao cromossomo X.

D) Correta. Todas as três modalidades citadas estão documentadas na genética da síndrome de Alport.

Nota crítica: Há ainda formas digênicas descritas na literatura; a existência dessas formas não altera a resposta.

Fundamentação: [R22]

3. Referências técnicas consultadas

As referências abaixo sustentam os comentários e permitem conferir as recomendações. Links destinados à leitura técnica; acesso verificado em 20/10/2026. Não se trata do gabarito oficial da instituição.

[R01] EAU. Paediatric Urology - Vesicoureteric reflux (versão vigente)
https://uroweb.org/guidelines/paediatric-urology/chapter/vesicoureteric-reflux

[R02] AAP. Clinical Practice Guideline for UTI in children 8 days to 5 years (2026)
https://publications.aap.org/pediatrics/article/158/4/e2026078565/209460/Clinical-Practice-Guideline-for-the-Diagnosis-and

[R03] AUA. Evaluation and Treatment of Cryptorchidism: Guideline
https://www.auajournals.org/doi/10.1016/j.juro.2014.05.005

[R04] IDSA. Catheter-Associated Urinary Tract Infection Guideline
https://academic.oup.com/cid/article/50/5/625/324341

[R05] CDC. Herpes - STI Treatment Guidelines
https://www.cdc.gov/std/treatment-guidelines/herpes.htm

[R06] CDC. Lymphogranuloma Venereum - STI Treatment Guidelines
https://www.cdc.gov/std/treatment-guidelines/lgv.htm

[R07] CDC. Anogenital Warts - STI Treatment Guidelines
https://www.cdc.gov/std/treatment-guidelines/anogenital-warts.htm

[R08] CDC. Laboratory Recommendations for Syphilis Testing (2024)
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/73/rr/rr7301a1.htm

[R09] KDIGO. CKD Guideline Executive Summary (2024)
https://kdigo.org/wp-content/uploads/2017/02/KDIGO-2024-CKD-Guideline-Executive-Summary.pdf

[R10] EAU. Non-neurogenic Male LUTS - Disease Management (2026)
https://uroweb.org/guidelines/management-of-non-neurogenic-male-luts/chapter/disease-management

[R11] MSD Manual. Bacterial Urinary Tract Infections
https://www.msdmanuals.com/professional/infectious-diseases/urinary-tract-infections/bacterial-urinary-tract-infections

[R12] Membranous Nephropathy: Core Curriculum 2021 (AJKD)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272638620311331

[R13] MSD Manual. Lupus Nephritis, membranous class V
https://www.msdmanuals.com/professional/multimedia/image/lupus-nephritismembranous-class-v

[R14] MSD Manual. Rapidly Progressive Glomerulonephritis
https://www.msdmanuals.com/professional/nephrology/glomerular-disorders/rapidly-progressive-glomerulonephritis-rpgn

[R15] ADA. Pathogenesis of Diabetic Nephropathy (2021)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK571720/table/db202112.T2/

[R16] KDIGO. Acute Kidney Injury and Acute Kidney Disease (documentos de orientação)
https://kdigo.org/guidelines/%20acute-kidney-injury/

[R17] ADQI. Acute Kidney Disease and Renal Recovery: consensus (2017)
https://www.nature.com/articles/nrneph.2017.2

[R18] KDIGO. Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease Guideline (2025)
https://kdigo.org/guidelines/autosomal-dominant-polycystic-kidney-disease-adpkd/

[R19] Genetic and Cellular Basis of ADPKD - gene PKD1/PKD2
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5741702/

[R20] NIDDK. Adult Glomerular Filtration Rate Equations
https://www.niddk.nih.gov/research-funding/research-programs/kidney-clinical-research-epidemiology/laboratory/glomerular-filtration-rate-equations

[R21] MSD Manual. Diabetic Nephropathy
https://www.msdmanuals.com/pt/profissional/nefrologia/doen%C3%A7as-glomerulares/nefropatia-diab%C3%A9tica

[R22] GeneReviews. Alport Syndrome
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1207/

[R23] Ultrasonography of Acute Flank Pain and Renal Stones
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6177687/

[R24] Acute Renal Failure: intrarenal causes review
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1601981/

[R25] Diabetic Kidney Disease - Endotext
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279103/

[R26] NICE. Chronic Kidney Disease: Assessment and Management
https://www.nice.org.uk/guidance/ng203/chapter/Recommendations

[R27] MSD Manual. FSGS overview
https://www.msdmanuals.com/professional/genitourinary-disorders/glomerular-disorders/focal-segmental-glomerulosclerosis

[R28] Diabetic nephropathy versus other causes of glomerulosclerosis
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1860608/

[R29] EAU. Paediatric Urology - Management of Undescended Testes
https://uroweb.org/guidelines/paediatric-urology/chapter/management-of-undescended-testes

[R30] NCBI Bookshelf. Urinary Obstruction, Stone Disease and Infection - emphysematous pyelonephritis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK543798/